

35 - 02-SÉMIOLOGIE THYROÏDIENNE - Pr. BAÏZRI

Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Alors l'autre fois, on a fait un cours de sémiologie du diabète sucré.

Et aujourd'hui, on va attaquer un autre chapitre de la sémiologie. Il s'agit de la sémiologie thérapeutique. Alors, parmi les objectifs de ce cours, c'est d'abord reconnaître un goitre, reconnaître un ondule théroïdien, reconnaître les signes cliniques d'une hyperthéroïdie et également reconnaître les signes cliniques d'une hypothyroïdie.

Alors, avant de commencer le cours, j'aimerais juste vous rappeler la régulation de la synthèse et de la sécrétion des hormones théroïdiennes. Comme vous le savez, que ce soit la T4 ou bien la T3, ils sont synthétisés et sécrétés par la glande théroïde sous l'action d'une autre hormone. C'est la TSH qui est sécrétée par l'hypophyse antérieure.

Et cette TSH est elle-même sous la dépendance d'un autre facteur, qui est la TRH, et qui est sécrétée au niveau hypothalamique. Et comme vous le savez, ça c'est presque une règle générale en endocrinologie, c'est que chaque fois qu'on a une sécrétion d'une hormone par une glande endocrine périphérique, il y aura ce qu'on appelle un feedback négatif, aussi bien au niveau hypophysaire qu'au niveau hypothalamique. Et cette notion est très importante à comprendre pour qu'on puisse comprendre également les anomalies biologiques et hormonales qu'on peut avoir au cours des thyroïdes, que ce soit l'hypo ou l'hyperthyroïde.

Alors on va commencer d'abord par la sémiologie des goitres. Alors c'est quoi un goitre ? Un goitre correspond à une augmentation du volume de la thyroïde. On a deux façons de faire, deux façons pour poser le diagnostic d'un goitre, soit cliniquement lorsque à la palpation la surface de chacun des lobes excède celle de la dernière phalange du pouce du patient, ou bien sur le plan échographique lorsque le volume thyroïdien qui est évalué par la somme de chacun des lobes excède 16 cm³ chez l'adolescent, quand il excède 18 cm³ chez la femme adulte et quand ça dépasse 20 cm³ chez l'homme.

Alors les goitres, il faut savoir que les goitres peuvent être congénitaux, c'est-à-dire qu'ils apparaissent à la naissance ou acquis au cours de la vie. Ils peuvent être défus ou localisés. Ils peuvent être normaux, hypo ou hyperfonctionnels, c'est-à-dire avec un état de thyroïde ou bien en hypothyroïde ou bien associé à une hypothyroïde.

Ils peuvent être bénins comme ils peuvent être malins. Alors l'histoire naturelle des goitres se constitue fréquemment à la période de l'adolescence. Ces goitres s'accroissent et s'organisent progressivement sous forme d'ondules au fil des années et des décennies.

Et puis il faut savoir également que certains facteurs ou bien certaines conditions participent au développement de ces goitres, notamment les grossesses, les stress de la vie et également la carence en iode. Alors sur cette diapo, vous avez un schéma qui montre l'évolution naturelle du

goitre simple. Alors au début, c'est la phase de latence.

Puis elle sera suivie généralement par une phase de disgrâce esthétique. Après, ça va être un goitre symptomatique, peut-être avec une douleur, une dysphagie, avant d'arriver au stade de complication, en particulier l'apparition de néoplasie au sein de ce goitre. Alors devant tout goitre thyroïdien, il faut bien évidemment faire une exploration clinique, en commençant par l'interrogatoire et en précisant en particulier l'âge.

Il faut également préciser l'origine géographique. Est-ce que le patient a vécu ou bien vit dans une zone de carence iodée? La présence ou non de pathologies thyroïdiennes familiales et en particulier les cancers thyroïdiens. Il faut rechercher une notion d'antécédent d'irradiation dans l'enfance.

Aussi, il faut voir est-ce qu'il n'y a pas de syndrome compressif chez ce patient sous forme de dysphonie, de dysphagie ou bien de dyspnée. Il faut également rechercher les signes d'hyper ou bien d'hypothyroïdie, sans oublier d'évaluer le profil évolutif de ce goitre. Est-ce qu'il est d'apparition récente ou bien il a rapidement augmenté de volume? Après cette anamnèse, on passe bien évidemment à l'examen de la thyroïde.

En commençant par l'inspection, la tête doit être en discrète extension et on recherche une éventuelle cicatrice, des signes inflammatoires en regard de l'air thyroïdien, une thuméfaction qu'on peut voir à l'inspection, une éventuelle circulation collatérale et parfois on a recours à ce qu'on appelle la manœuvre de Pamperton qui est illustrée sur cet diapositif. L'objectif est la recherche de signes de compression veineuse qui vont être démasqués par cette manœuvre. Après l'inspection, il faut faire une palpation de la thyroïde et l'examineur doit se placer en principe derrière le patient et le patient, de préférence, il faut qu'il soit assis sur une chaise, la tête fléchie et généralement on palpe avec la pulpe des doigts, bien sûr sans le pouce, et cette palpation se fait au repos, puis pendant un mouvement de déglutition, en faisant boire le sujet à petite gorgée, tout en sachant que la thyroïde est mobile avec les mouvements de déglutition.

Au cours de cette palpation, il faut déterminer le volume du couâtre, sa consistance, est-ce qu'il est souple, ferme ou dur, son homogénéité, est-ce qu'il est homogène, défuit, sans formation nodulaire ou bien il y a la présence de formation nodulaire, sa sensibilité, est-ce qu'il est douloureux ou insensible, et également essayer de voir est-ce qu'il est plongeant ou non. Sans oublier de rechercher un éventuel trill, qui est une sensation de frémissement, qu'on peut trouver surtout dans les couâtres vasculaires, dans le cadre de la maladie de base d'eau, sans oublier de rechercher la présence d'éventuelles adénopathies cervicales, et on termine l'examen clinique de la thyroïde qui parle d'une auscultation à la recherche d'un souffle vasculaire. Sur cette diapo vous avez deux photos, la photo qui est en haut montre les repères anatomiques pour la palpation de la thyroïde, et la photo qui est en bas montre la technique de la palpation et de l'examen de la thyroïde.

A l'issue de cet examen, on peut classer les couâtres en fonction de la classification OMS. Un couâtre est classé stade 0 quand la thyruide est non palpable ou bien palpable, mais dont les lobes sont de volume inférieur à la phalange distale du poste du sujet examiné. Un couâtre stade 1A correspond à une thyruide nettement palpable et dont les lobes ont un volume supérieur à la phalange distale du poste du sujet examiné, mais non visible lorsque la tête est en extension.

Un couâtre stade 1B correspond à une thyruide nettement palpable et dont les lobes ont un volume supérieur à la phalange distale du poste du sujet examiné, mais cette fois-ci visible lorsque la tête est en extension, mais non visible en position normale. Un couâtre stade 2 correspond à une thyruide nettement visible lorsque la tête est en position normale et un couâtre stade 3 correspond à une thyruide volumineuse visible à plus de 5 mètres. Et là vous avez des exemples de couâtres.

Sur la photo qui est à gauche, il s'agit d'un couâtre stade 2. Sur la photo qui est au milieu, il s'agit d'un couâtre homogène stade 2. Pour la photo qui est à droite, elle correspond à un couâtre nodulaire stade 3. Après l'examen clinique, il faut faire bien évidemment une exploration paraclinique et devant un couâtre d'allure simple, et quand on parle de couâtre d'allure simple c'est que c'est un couâtre qui est défus, homogène, non fonctionnel, non inflammatoire. Et devant ce type de couâtre, on demande généralement deux examens paracliniques. Le premier c'est le dosage de l'ATSH pour s'assurer que ce couâtre revient pour s'assurer de l'état de thyruidie.

Et puis le deuxième examen paraclinique c'est une échographie cervicale. Alors l'échographie cervicale, elle va préciser l'échogénicité du couâtre, ses mensurations, et puis elle va rechercher également la présence d'éventuels nodules en précisant leur nombre, leur forme, leur situation, les limites, les classification, également le type de vascularisation au sein de ces nodules. Ces caractéristiques vont nous permettre de classer les nodules en fonction de la classification Eutairades, sans oublier bien évidemment de rechercher des adénopathies à l'échographie.

Vous avez là deux images échographiques, en coupe transversale à gauche et en coupe longitudinale à droite, qui montrent la présence de multiples nodules hypoécogènes, hétérogènes d'un couâtre multinodule. Alors si on a un doute sur la présence d'un couâtre plongeant, on peut compléter les explorations soit par une radiographie thoracique de face, soit par une TDM, bien évidemment à la recherche d'une éventuelle déviation tracheale. Comme vous voyez sur cette diapositive, à gauche vous avez une radio-thoracique qui montre un élargissement du médiastin en rapport avec un couâtre plongeant, et à droite vous avez une coupe scanographique montrant un couâtre avec un prolongement dans le médiastin onterosupérieur.

A l'issue de cette première phase d'examens cliniques et d'examens paracliniques basés sur le dosage de la TSH et l'échographie, et éventuellement une radio-pulmonaire, voire même une TDM cervico-thoracique, les autres examens complémentaires seront demandés selon l'orientation clinique ou le résultat des examens précédents. Si la TSH revient à normal, on peut compléter le bilan par le dosage des hormones thyroïdiennes périphériques, en particulier la T4

libre et ou la T3 libre. Si on suspecte une thyroïdie auto-immune, dans ce cas on peut compléter le bilan par le dosage des anticorps anti-thyropéroxydase, dit également anticorps anti-TPO, et s'ils sont négatifs, on peut compléter le bilan par les anticorps anti-thyroglobuline, appelés également anticorps anti-TG.

Si on est devant une suspicion de maladie de base d'eau, dans ce cas on peut demander les anticorps anti-acétose de la TSH, et puis si on suspecte un cas sino-médulaire, le dosage de la calcitonine est recommandé. Comme autre examen complémentaire, on peut faire une cytoponction éco-guidée d'un nodule thyroïdien suspect de malignité. Cette cytoponction est effectuée à l'aiguille fine.

C'est l'examen clé à la condition d'être réalisé avec une technique de prélèvement et de lecture rigoureuse. La scintigraphie thyroïdienne aux techniciens n'est demandée que si on est devant un tableau d'hyperthyroïdie associée. Là vous avez quelques exemples d'aspects scintigraphiques.

À gauche vous avez un aspect scintigraphique d'une maladie de base d'eau. Vous voyez l'hyperfixation intense qui intéresse les deux lobes. Au milieu vous avez un aspect scintigraphique d'un goitre multinodulaire toxique avec des nodules dits chauds ou bien toxiques, hyperfixants et d'autres nodules qui sont froids.

Et puis sur l'image à droite, vous avez un aspect scintigraphique d'un nodule toxique isolé qui fixe avec extinction du reste du parenchyme thyroïdien. Alors ce qu'il faut retenir au terme de cette première partie, c'est que chez certaines personnes l'angine, la thyroïde peut être palpable et donner une impression de goitre. C'est la raison pour laquelle il faut généralement compléter par une échographie pour avoir une idée précise sur les mensurations de la thyroïde.

Et inversement, l'appréciation clinique d'un goitre est difficile en cas d'obésité. Au terme de cette évaluation clinique et paraclinique, le goitre est dit simple si l'hypertrophie de la thyroïde est diffuse, normofonctionnelle, c'est-à-dire le bilan thyroïdien est strictement normal, non inflammatoire, le bilan immunologique est également normal et non cancéreuse. Après avoir parlé de la séméiologie du goitre, on va passer maintenant à la séméiologie du nodule thyroïdien qui est une situation qui devient de plus en plus fréquente.

En rappelant que le nodule correspond à toute hypertrophie localisée de la glande thyroïde, tout à l'heure on a parlé du goitre, c'est une hypertrophie totale et globale de la glande thyroïde, le nodule c'est juste une hypertrophie localisée de la glande thyroïde. Il faut savoir également que la majorité des nodules thyroïdiens sont bénins et constituent la première manifestation d'une dystrophie plurinodulaire et puis les cancers ne sont retrouvés que dans 5% des cas, en principe de très bon pronostic lorsqu'ils sont reconnus, pris en charge et traités à ce stade nodulaire. Bien évidemment, devant tout nodule thyroïdien, il faut faire une évaluation initiale en se basant sur une anamnèse et au cours de cette anamnèse ou bien cet interrogatoire, il faut préciser l'âge et

le sexe, puisque un nodule est considéré comme suspect aux deux âges extrêmes et chez l'homme.

Il faut également préciser l'origine géographique, c'est la même chose que pour un goitre, voir est-ce que le patient ne vit pas ou bien n'a pas vécu dans une zone de carence iodée. Le mode d'installation est très important devant tout nodule thyroïdien, est-ce que c'est une installation qui est rapide, récente ou bien c'est un nodule qui remonte à plusieurs années ou bien à plusieurs mois. Les signes associés, notamment la douleur, des signes compressifs, des signes de thyrotoxicose.

Avoir une idée sur la vitesse d'augmentation de la taille et on considère qu'un nodule est suspect s'il y a eu une augmentation de plus de 20% de son volume ou bien du contexte en un an. Avoir une idée sur les antécédents personnels d'irradiation cervicale pendant l'enfance, sur les antécédents familiaux et en particulier de cancer thyroïdien dans la famille et également rechercher la notion de diarrhée et de flash syndrome. Après cet interrogatoire, il faut faire un examen clinique en précisant le siège de son nodule, sa taille, bien évidemment il faut faire attention au nodule dont la taille dépasse 3 ou 4 cm.

La consistance de son nodule est très importante à évaluer, est-ce qu'il s'agit d'un nodule qui est mou, élastique, ferme, irrégulier, dur ou pierreux. La mobilité par rapport aux deux plans, rechercher la présence ou non de signes inflammatoires et également rechercher la présence ou non d'adhésion en partie cervicale associée. Et puis à l'issue de cet examen clinique très méthodique, il faut compléter le bilan par une TSH et une échographie.

Alors dans certaines situations cliniques, le contexte oriente déjà vers un diagnostic précis, limitant le recours à d'autres explorations. Ainsi, si on est devant une tumefaction cervicale ou bien tumefaction au sein de la thyroïde d'apparition brutale et douloureuse, il peut s'agir d'hématocènes. Quand on est devant un nodule douloureux associé à une fièvre, il peut s'agir d'une thyroïde subaiguë de deux carpins.

Si le nodule est compressif associé à des adénopathies, ça peut s'agir d'un cancer. Aussi, si le nodule est associé à un tableau de thyrotoxicose, très probablement il s'agit d'un nodule toxique. Et puis, si le nodule est associé à des signes d'hypothyroïdie, il peut s'agir d'une thyroïde lymphocytaire.

Alors, les autres situations qui sont les plus communes, c'est généralement des nodules en apparence isolés, sans signes associés. Je rappelle que la majorité de ces nodules sont bénins, mais il ne faut pas passer à côté d'un éventuel cancer. Et puis, en fonction de l'ATSH, on peut compléter le bilan par d'autres explorations, notamment le bilan immunologique, l'échographie, j'en ai parlé pour avoir une idée sur la classification Eutairades de ces nodules, et ça c'est très important.

Actuellement, on ne peut pas suivre ou bien prendre en charge un nodule thyroïdien sans qu'on

ait une échographie bien faite qui nous permet d'avoir une idée sur la classification Eutairades de ce nodule. On peut avoir également recours à la cytoponction et également à une scintigraphie. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses que j'ai répétées, entre des choses que j'ai dites, j'en ai parlé dans le cours de scéniologie du gouâtre, et là, c'est pratiquement la même chose, parce qu'un gouâtre simple, c'est un gouâtre sans nodule non fonctionnel et non inflammatoire, mais parfois, ce gouâtre simple, au sein de ce gouâtre simple, il peut se développer des nodules, et la conduite à tenir, c'est très important.

Ainsi, devant tout nodule thyroïdien en apparence isolé, on demande, comme je l'ai dit tout à l'heure, en premier une TSH, et si la TSH revient basse, il s'agit très probablement d'un nodule hyper fonctionnel, c'est-à-dire un nodule chaud toxique, et dans ce cas, c'est la seule indication pour réaliser une scintigraphie. Si la TSH revient normale, dans ce cas, il peut s'agir d'un nodule bénin comme il peut s'agir d'un cancer, qu'on retrouve dans 5% des cas, et dans ce cas, il faut compléter le bilan par une échographie et éventuellement la cytoponction, plus ou moins la calcitonine. Si la TSH est augmentée, ça veut dire que le patient est en hypothyroïdie, dans ce cas, on complète le bilan par le dosage des anticorps anti-TPO, éventuellement les anticorps anti-TG si les anticorps anti-TPO reviennent négatifs, à la recherche d'une éventuelle thyroïdite.

Là, vous avez le score E-thyrase qu'on utilise pour classer les nodules thyroïdiens. Vous voyez qu'on peut avoir des nodules thyroïdiens classés E-thyrade 5 avec au moins un signe de forte suspicion. Vous avez les différentes caractéristiques d'un nodule qui est fortement suspect.

Il peut s'agir d'un nodule classé E-thyrade 4, E-thyrade 3 ou E-thyrade 2. Là, vous avez des images qui montrent les différentes caractéristiques faisant suspecter ou faisant classer un nodule E-thyrade 5, comme la forme non ovale, les contours irréguliers, la présence de microcalcifications au sein du nodule et également le caractère hypoécogène très marqué du nodule. Après cette première étape basée sur le dosage de la TSH et l'échographie en précisant le thyrate du nodule, on peut avoir recours à la cytoponction devant un nodule suspect cliniquement et ou échographiquement. Il s'agit d'une étude cytologique à l'aiguille fine qui est l'examen le plus sensible.

Comme j'ai dit au début, elle est indispensable pour tous les nodules cliniquement ou échographiquement suspects ou déterminés. Elle permet de reconnaître 50 à 95% des cancers, mais ceci dépend de l'expérience de celui qui va faire la ponction et celui qui va faire la lecture cytologique. Elle contribue à la surveillance des nodules non opérés.

La présence des résultats de l'examen cytologique est maintenant codifiée en fonction du référentiel de Bethesda 2017. Chaque classe de ce référentiel fournit une orientation pronostique. Ce qu'il faut retenir, c'est que les nodules thyroïdiens sont fréquents.

Le risque est heureusement très faible, 5% de risque d'avoir un cancer. Devant tout nodule d'allure isolée, il faut demander d'abord la TSH et l'échographie. Le suivi d'une démarche

diagnostique rigoureuse est le meilleur garant pour ne pas passer à côté d'un éventuel cancer.

Après avoir parlé des anomalies morphologiques de la thyroïde, notamment les goitres et les nodules, on va aborder un autre chapitre qui va être consacré aux anomalies fonctionnelles et en particulier les hyper- et les hypothyroïdies. On va commencer par la sémiologie des hyperthyroïdies périphériques. Je rappelle que l'hyperthyroïdie périphérique est la conséquence d'une élévation notable des hormones thyroïdiennes, la T4 et la T3.

C'est une affection fréquente. A côté des signes d'hyperthyroïdie, qu'on appelle un syndrome thyro-toxique ou bien une thyro-toxicose, peuvent se rajouter d'autres signes en rapport avec l'étiologie. L'intensité des signes dépend de la gravité de l'hyperthyroïdie, de sa durée et du terrain.

Ce sont des signes généraux, une thermophobie fréquente associée à une polydipsie conséquente. Les mains sont moites et chaudes et ces signes cliniques sont en rapport avec une production importante de chaleur. En plus des signes généraux, un patient qui est en hyperthyroïdie peut avoir des manifestations cardiovasculaires avec des palpitations au repos.

Parfois une tachycardie sinusale qui est permanente, aggravée à l'effort et à l'émotion. Les peaux sont généralement amples et bondissantes. On note aussi une légère élévation de la pression artérielle systolique et parfois un souffle systolique au niveau des grosses artères.

En cas d'hyperthyroïdie, on peut avoir également des manifestations digestives avec l'installation d'une diarrhée ou bien disparition d'une constipation chronique connue. Des manifestations neuromusculaires peuvent également se voir au cours d'une hyperthyroïdie avec une amyotrophie des ceintures et des quadriceps, une asthénie musculaire avec difficulté à se relever. Devant tout patient qui présente un syndrome thyro-toxique, généralement on recherche le signe du tabouret qui correspond à une manœuvre en demandant au patient de s'accroupir et d'essayer de se relever sans l'aide de ses deux bras.

Si le patient réussit à le faire, c'est bon. On peut dire que le signe du tabouret est négatif. S'il n'y arrive pas, le signe du tabouret est considéré comme positif.

Toujours en rapport avec les manifestations neuromusculaires, on peut avoir un tremblement d'altitude des extrémités. C'est un tremblement qui est rapide, fin et régulier et qui est très manifeste au niveau des mains. Parfois, il est très discret.

On a un recours à ce qu'on appelle le signe du papier. Le patient tend ses deux mains et on pose une feuille de papier sur les deux mains. A travers cette manœuvre, on peut voir s'il y a un tremblement ou non des deux mains.

Le patient ou les patients qui ont une hyperthéroïdie peuvent également avoir comme manifestation neuromusculaire une nervosité, une agitation, une insomnie, une irritabilité. Et puis,

comme autre manifestation, un patient qui est en hyperthéroidie peut avoir d'autres signes extra-théroidiens, en particulier une rétraction de la paupière supérieure, qui est responsable d'une asynergie oculomotrice. Et puis, sans oublier également la présence d'éventuels troubles des règles, d'une dysfonction érectile, une baisse de la libido.

Sur cette diapo, vous avez quelques exemples d'ophtalmopathies qu'on peut avoir, qu'on peut voir au cours des hyperthéroidies. En haut et à gauche, vous avez un éclat de regard avec rétraction palpébrale. En haut et à droite, vous avez une orbitopathie inflammatoire associée à une exophtalmie.

Et en bas et au milieu, vous avez une orbitopathie avec chémosis palpébrale supérieure et inférieure. Devant tout, syndrome thyro-toxique ou bien de thyro-toxicose, je rappelle que quand on parle de syndrome thyro-toxique, c'est sur le plan clinique. Et devant tout syndrome thyro-toxique, pour poser le diagnostic d'une hyperthéroidie, on a besoin de dosages hormonaux, notamment le dosage surtout de la TSH et puis éventuellement qui va être complété par le dosage de la LT4 et ou de la LT3.

Et dans le cadre des hyperthéroidies, pour poser le diagnostic d'une hyperthéroidie, il faut qu'on ait une TSH basse, parfois très effondrée, en regard ou bien associée à un taux de LT4 élevé et ou de LT3 également élevé. A côté de ces deux signes ou bien de ces deux anomalies hormonales spécifiques, on peut avoir d'autres signes biologiques non spécifiques sous forme d'une leucocytose avec une lymphocytose relative, une élévation des enzymes hépatiques, une diminution du cholestérol et des triglycérides, parfois une hypercalcémie modérée et parfois une discrète hyperglycémie mais surtout une aggravation d'un diabète préexistant. Le diagnostic étiologique généralement se fait en fonction du contexte et il fait appel à l'échographie, la scintigraphie thyroïdienne et également le dosage des anticorps, en particulier les anticorps anti-TPO et les anticorps anti-récepteurs de la TSH.

Alors ce qu'il faut retenir au terme de cette troisième partie, c'est que le syndrome thyro-toxique ou bien thyro-toxicose est la traduction clinique des hyperthyroïdies périphériques. Ce syndrome est commun à toutes les étiologies des hyperthyroïdies. Certains signes extrathyroïdiens, en particulier les signes ophtalmologiques, peuvent orienter vers l'étiologie et puis le diagnostic positif repose sur le couple TSH-LT4 et ou LT3.

Alors l'hypothyroïdie c'est l'ensemble des manifestations liées à l'insuffisance, l'imperfection ou la non-utilisation de la sécrétion thyroïdienne. Elle est bien évidemment plus courante chez la femme de plus de 50 ans. Sur le plan clinique, les manifestations sont classées en deux catégories.

Il y a des signes cutano-muqueux et des signes d'hypométabolisme. Alors le syndrome cutano-muqueux correspond à l'infiltration du cutano-muqueuse qui réalise le tableau de Myxoderm. Elle concerne la peau, les tissus sous-cutanés et les muqueuses et l'effet de substances myxoïdes

riches en mycopolysaccharides.

Ainsi, on peut avoir chez un patient qui est en hypothyroïdie une infiltration de la peau qui devient sèche, pâle ou jaunâtre, squameuse, le visage est arrondi avec les lèvres épaissies, les paupières sont parfois oedématisées, les creux susclaviculaires sont comblés et les mains et les pieds boudinés. Sur le plan des muqueuses, on peut avoir une infiltration des cordes vocales responsables d'une rossité de la voix et des ronflements nocturnes, une hypoacousie secondaire à l'infiltration de la trempe de stache, une macroglossie secondaire à une infiltration de la muqueuse ou bien de la langue. L'infiltration de la face dorsale des mains peut être responsable d'un syndrome du canal carpien.

Au niveau du visage, on peut avoir une infiltration pouvant donner un aspect de faciès lunaire et sans oublier les troubles dépannaires sous forme d'une dépilation de la queue des sourcils, des cheveux secs et cassants et parfois une dépilation pubienne et axillaire. Concernant le syndrome d'hypométabolisme, elle se manifeste par un ralentissement global des différentes fonctions de l'organisme. Chez le patient qui est en hypothyroïdie, on peut avoir une asthénie physique, intellectuelle et sexuelle, un ralentissement psychomoteur, l'idéation avec des troubles de concentration et une somnolence, parfois une frilosité précoce, une bradycardie associée parfois à une insuffisance coronaire rarement symptomatique ou bien une asthéia diastolique, une constipation et également une diminution de la puissance.

En plus des signes cutanéo muqueux et des signes ou bien du syndrome d'hypométabolisme, on peut avoir un ralentissement endocrinien dans le cadre des hypothyroïdies avec une galactorie qui reste rare et qui se voit généralement quand on a une hyperprolaxinémie en cas d'hypothyroïdie primaire profonde. Donc c'est une hyperprolaxinémie secondaire à l'hypothyroïdie profonde avec un TSA généralement supérieur à 50 mL par litre. Et puis on peut également avoir des troubles des règles sous forme d'oligoménorrhées, de ménorragie, d'anovulation et aussi des troubles de la libido.

Là sur cette diapositive vous avez deux photos. La première à gauche qui montre les signes d'infiltration au niveau du visage avec aussi la perte de la queue des sourcils. Et puis à droite vous avez un mixe d'EDEM des pieds.

Il faut savoir qu'il y a une différence entre le mixe d'EDEM et l'EDEM. Alors au niveau thyroïdien, en fonction de l'étiologie, on trouve soit un goitre soit à l'inverse une atrophie glandulaire. Et sur le plan paraclinique, la confirmation de l'hyperthyroïdie fait appel au dosage de la TSH qui va revenir élevé en présence d'une hypothyroïdie périphérique.

La T4 est abaissée et n'a d'intérêt que d'en évaluer la profondeur. C'est pas la peine de demander le couple TSH T4 devant la suspicion d'une hypothyroïdie. Seule la TSH est largement suffisante, mais généralement on demande aussi la T4 pour avoir une idée sur la profondeur de cette hypothyroïdie.

Par contre, dans l'insuffisance thyroïdienne, la TSH peut être normale ou basse et la T4 libre, en regard, est abaissée. Alors sur le plan biologique, comme signe biologiquement spécifique, il peut y avoir une anémie souvent macrocytaire, une hypercholestérolémie, parfois une hypertriglycéridémie, une hyponatrémie de dilution qui peut être très profonde, et parfois une augmentation des transaminases, et comme j'ai dit tout à l'heure, parfois également, c'est rare, une hyperprolactinémie secondaire, une hypothyroïdie périphérique qui est très profonde. Et on peut avoir également d'autres anomalies paracliniques, comme un microvoltage ou bien un aplatissement, une inversion des entées à l'ECG, et une cardiomégalie par infiltration du péricarde sur la radio du thorax ou bien l'échographie thoracique cardiaque.

Alors à la fin, ce qu'il faut retenir, c'est que le mixte d'œdème putané et ferme ne prend pas le godet, il faut le différencier de l'œdème habituel qui est généralement mou, il prend le godet, la prise de poids modérée observée dans l'hypothyroïdie est due à l'infiltration alors que l'appétit est diminué, et puis à la fin, la confirmation hormonale de l'hypothyroïdie périphérique fait appel à la TSH seule et l'hypothyroïdie centrale nécessite le dosage du couple hormonal TSH et LT4. Je vous remercie pour votre attention.